ONEMA-POP-050 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

ONEMA-POP-050 — Segurança diante de Rompimento ou
Danificação Externa de Cateter Venoso Central (PICC/Hickman)

1. Identificação institucional

técnica

2. Objetivo e abrangência

Padronizar a atuação de enfermagem em: Segurança diante de Rompimento ou Danificação Externa de Cateter Venoso Central (PICC/Hickman). Aplicável a visitas e/ou triagem digital conforme pertinência, sem substituir serviço de emergência.

3. Competência, indicações e contraindicações

Enfermeiro habilitado, treinado e autorizado; Rompimento, fissura ou dano externo de PICC/Hickman; risco de sangramento, embolia aérea e contaminação. Não realizar intervenções além da competência, prescrição ou recursos disponíveis.

4. Materiais e equipamentos; fornecimento

Enfermeiro: luvas, gaze estéril, material para curativo, clamp compatível quando previsto pelo fabricante; paciente: documentação do dispositivo. Equipamentos de avaliação clínica de uso profissional são providos pelo enfermeiro; consumíveis do paciente conforme contratação.

5. Avaliação clínica e preparação

Local do dano, vazamento, sangramento, posição, presença de clamp, sintomas respiratórios e tempo desde evento. Confirmar identificação, consentimento, privacidade e localização para eventual emergência.

6. Execução técnica individualizada

1. Interromper infusão e bomba imediatamente; não reiniciar pelo lúmen danificado.

2. Avaliar dispneia, dor torácica, tontura, sangramento e sinais de instabilidade.

3. Proteger extremidade danificada de contaminação com técnica asséptica, sem introduzir material no lúmen.

4. Se protocolo do dispositivo autorizar e profissional treinado, ocluir/clamp proximal ao dano sem esmagar ou

lesar o cateter.

5. Não cortar, reparar, colar ou trocar conexões improvisadamente no domicílio.

6. Manter paciente em segurança e contatar equipe de acesso vascular para avaliação urgente.

7. Se suspeita de embolia aérea ou deterioração, acionar SAMU 192 e seguir orientação da equipe de emergência.

8. Documentar tipo, localização do dano, intervenções e destino do paciente.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Dispneia súbita, dor torácica, síncope, sangramento importante ou suspeita de embolia: emergência imediata.

8. Cuidados posteriores e orientações

Orientar não utilizar ou manipular o acesso até avaliação especializada.

9. Registros obrigatórios na Carteira Digital ONEMA

Registrar identificação, data/hora, modalidade, consentimento, queixa, avaliação, achados positivos/negativos, etapas realizadas, intervenções não realizadas e justificativa, comunicação com RT/rede, encaminhamento, orientações, plano de retorno e assinatura do enfermeiro.

10. Referências específicas e rastreáveis

 CDC — Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections (review 2024) — https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/intravascular-catheter-related-infection/

 COFEN — Resolução 736/2024, Processo de Enfermagem — https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-736-de-17-de-janeiro-de-2024/

Referências consultadas como suporte temático; a correspondência exaustiva entre cada passo e a evidência, bem como regras locais e manuais dos fabricantes, requer análise pelo RT.